

La cistoscopia permite a su cirujano mirar dentro de su uretra y vejiga usando un telescopio delgado con una cámara y luz diminutas, que se pasa suavemente por la abertura natural de la orina. Ayuda a encontrar la causa de la sangre en la orina, infecciones, estrechamientos u otros problemas de la vejiga — y a revisar una reparación.

Acerca de esta prueba

Un **cistoscopio** es un tubo delgado con una cámara en el extremo. Hay dos tipos:

- Un **cistoscopio flexible (que se dobla)** se usa por lo general en el consultorio mientras usted está despierto, con gel anestésico.
- Un **cistoscopio rígido (recto)** se usa en el quirófano mientras usted está dormido, y permite al cirujano también tratar un problema en la misma visita.

Se introduce líquido estéril para abrir suavemente la vejiga y poder ver con claridad sus paredes. Su cirujano puede indicar una cistoscopia para:

- Encontrar la causa de la **sangre en la orina** o de infecciones repetidas
- Buscar una **estrechez (estenosis)**, una piedra o un crecimiento
- Revisar cómo está sanando una reparación, o tomar una pequeña muestra (biopsia)
- Colocar, revisar o retirar un **stent** o un punto de sutura

¿Es segura?

Sí. La cistoscopia es una de las pruebas urológicas más comunes y es de bajo riesgo. La mayoría de las personas solo tienen una molestia breve. Los efectos secundarios poco frecuentes — una infección de orina, un poco de sangrado, o ardor de corta duración o dificultad para orinar — suelen ser leves y pasan rápido.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Cistoscopio

Un telescopio delgado con una cámara y luz que se usa para mirar dentro de la vejiga.

Vejiga

El saco muscular que almacena la orina hasta que usted orina.

Uretra

El conducto que lleva la orina fuera del cuerpo.

Flexible vs. rígido

Un instrumento que se dobla (despierto, en el consultorio) o un instrumento recto (dormido, en el quirófano).

Gel anestésico

Un anestésico local que se coloca en la uretra para que el instrumento pase con comodidad.

Biopsia

Una pequeña muestra de tejido que se toma para examinarla bajo el microscopio.

Stent

Un tubo blando que mantiene abierto un conducto; puede colocarse o retirarse durante la prueba.

Orina residual posmiccional

La cantidad de orina que queda en la vejiga después de orinar.

¿LE DOLERÁ? Con un instrumento flexible puede sentir presión breve o escozor cuando pasa — el gel anestésico ayuda, y una prueba en el consultorio por lo general termina en pocos minutos. Con un instrumento rígido usted está dormido bajo anestesia y no siente nada durante la prueba. Avise al equipo en cualquier momento si tiene molestias.

Cómo prepararse (antes de su prueba)

- Para una cistoscopia **en el consultorio (flexible)**, por lo general puede **comer, beber y tomar sus medicinas habituales**, y manejar de regreso a casa.
- Para una cistoscopia **bajo anestesia**, siga las instrucciones de su cirugía — el ayuno, qué medicinas suspender, y organice quién lo lleve a casa.
- Es posible que le pidan una **muestra de orina** para revisar si hay infección, y que le den un **antibiótico**.

Avise a su equipo con anticipación si usted:

- Toma un **anticoagulante**
- Tiene señales de una **infección de orina** (ardor, fiebre, u orina turbia y con olor fuerte) — una infección activa puede hacer que se reprogramme la prueba
- Tiene alguna alergia, o un estrechamiento que hizo difícil pasar un instrumento en el pasado

Qué sucede durante la prueba

- 1 Usted se recuesta cómodamente y el equipo lo ayuda a colocarse en posición. Se limpia la abertura y se coloca el gel anestésico.
- 2 El cistoscopio se pasa suavemente por la uretra hasta la vejiga.
- 3 Entra líquido estéril para abrir la vejiga, y su cirujano examina el revestimiento por completo alrededor.
- 4 Se retira el instrumento. Si se planea un tratamiento, una biopsia o un cambio de stent, se hace antes de sacar el instrumento.

Después de la prueba

- Después de una prueba en el consultorio, por lo general puede volver a sus **actividades normales de inmediato**; después de la anestesia descansa y necesita que alguien lo lleve a casa.
- Puede sentir un **ardor leve al orinar** durante un día más o menos. Beber agua adicional ayuda a eliminarlo y alivia esto.
- Puede notar un **tono rosado** en su orina por un corto tiempo. Esto es común y por lo general desaparece en un día.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dificultad para orinar, o no puede orinar nada
- Sangrado abundante, o coágulos de sangre en la orina
- Dolor que empeora en lugar de mejorar

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La cistoscopia es una mirada rápida y segura dentro de su vejiga y uretra con una cámara delgada — ayuda a su cirujano a encontrar un problema o a revisar una reparación.
2. Hay poco que hacer para prepararse para una prueba en el consultorio. Para una prueba bajo anestesia, siga sus instrucciones de ayuno y organice quién lo lleve a casa. Avise a su equipo sobre anticoagulantes o señales de una infección.
3. Un ardor leve o un poco de rosado en la orina durante un día es normal — beba agua adicional, y llame si tiene fiebre, sangrado abundante o dificultad para orinar.